

07 - 04.1- Troubles des conduites sexuelles - Pr. Adali

(0:37 - 1:54)

Pour vous, c'est psychiatre, psychologue, sexologue, les autres, gynéco, gynécologue, urologue, médecin généraliste, aucun intérêt, vous savez ou vous ne savez pas? Déjà, si on vous enseigne les troubles sexuels lors des études médicales, c'est qu'en tant que médecin généraliste, vous avez forcément un rôle dans la gestion de ces troubles. Pourquoi on s'intéresse à la sexualité à votre avis? C'est un chapitre à part entière, ce qui est aussi important que, par exemple, les troubles psychiatriques de la grossesse et du postpartum. Allez-y, répondez.

(1:56 - 2:33)

C'est une question de... C'est pas la même valeur? Alèche? Oui, mademoiselle. Je vous le dis dès maintenant, l'homosexualité n'est pas considérée, en fait, n'est plus considérée comme un trouble sexuel. Je vous le dis dès maintenant.

(2:34 - 3:16)

C'est pas moi qui le dis, c'est le DSM. C'est le manuel diagnostique et statistique des maladies mentales et on va en parler, on va en toucher un mot dans le cours. L'homosexualité est traitée, mais si traitée, et les prises en charge, par exemple, en psychiatrie ou en psychothérapie, que lorsqu'elle est source de souffrance pour le patient, pour la personne, et que c'est la personne qui vient vous voir pour une souffrance X. C'est la seule situation où vous allez trouver, où là vous pouvez prendre en charge l'homosexualité en tant que, je dirais pas pathologie, mais en tant que problématique.

(3:17 - 4:27)

Autrement, le DSM, le manuel statistique et diagnostique des pathologies psychiatriques, ne considère pas l'homosexualité comme un trouble sexuel. Oui, monsieur, vous vouliez dire, un spécialiste peut être d'origine organique. J'ai vu des cas de divorce, pour vous dire, chez des médecins, à cause des problématiques de sexualité.

(4:29 - 5:43)

La sexualité est une composante importante du bien-être global de l'individu, que vous le veuillez ou non. La sexualité est aussi importante que l'alimentation et qu'elle est une composante primordiale dans la vie d'un être humain, d'accord? Si vous êtes conscient de ça et vous êtes convaincu de cette importance, de l'importance de la sexualité, vous pouvez convaincre vos patients de ça et vous pouvez bien les prendre en charge et prendre leur plainte au sérieux. On va voir dans quelles situations la sexualité est mise entre parenthèses et on n'en parle même pas.

Dans des situations particulières, on va en parler. Donc, la sexualité est une composante de la santé, comme la santé mentale, santé physique, santé sexuelle, composante de la santé. Vous l'avez bien dit, les troubles sexuels sont rarement abordés spontanément par le malade, encore moins par le médecin.

(5:43 - 6:31)

Je vois que des personnes entre vous, quand on a parlé des troubles sexuels, c'est normal, c'est normal. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de ma faute. La sexualité est toujours, même dans les pays développés, parler de la sexualité librement et facilement est quelque chose de difficile et pour le patient et pour le médecin, d'accord? Parce que ce n'est pas un sujet qu'on prend au sérieux en pratiquant la sexualité et ce n'est pas un sujet, malgré que la sexualité est une composante importante du bien-être, est une composante de la santé.

(6:32 - 6:58)

Deuxièmement, on n'est pas formé à comment aborder la sexualité. C'est l'équivalent, je dirais, de la difficulté de l'annonce, par exemple, d'une maladie grave à un patient. On ne sait pas comment faire et du coup, on a peur de le faire, d'accord? Vous l'avez bien dit, le médecin généraliste est le premier contact du patient.

(6:59 - 7:27)

Donc, s'il y a une problématique sexuelle, c'est le médecin généraliste qui va être mis au courant en premier. L'important aussi, c'est que ça altère la qualité de vie et altère la continuité ou la pérennité du couple. Vous avez dit que j'ai vu énormément de couples divorcés à cause de problématiques, justement de baisse de la libido, de douleur au cours de l'acte sexuel qu'on appelait auparavant diasparodie.

(7:27 - 7:50)

Ça a entraîné des patients, j'ai eu des patientes qui ont divorcé, qu'au jour de leur divorce, elles étaient toujours vierges parce qu'il y avait une dyspareunie, un vaginisme important qui a empêché toute relation sexuelle pendant un an. Et là, le mari, il en a eu marre. C'est des couples de médecins.

(7:50 - 8:16)

Ces deux couples-là qui ont divorcé, c'est des médecins. Pour vous dire ça, si c'est le cas pour des médecins, imaginez pour des gens qui n'ont pas l'information scientifique, qui ne sont pas formés en médecine comme vous. D'accord ? Je viens de le dire, les praticiens ne sont pas formés et surtout, on aborde la sexualité.

(8:17 - 8:55)

Vous êtes les premiers intervenants en la matière avec le patient, mais parfois, des réelles problématiques sexuelles peuvent être traitées rien que par une information correcte. Le couple, la personne qu'on a besoin, et des conseils d'hygiène de vie très simples peuvent résoudre le problème sans pour autant aller voir le spécialiste sexologue, urologue ou gynécologue. D'accord ? Un historique juste pour montrer l'évolution du concept de sexualité.

(8:56 - 9:27)

Là encore, je reviendrai à ce que j'ai dit dans le cours des troubles des conduites alimentaires, que la sexualité aussi, elle obéit aux règles des sociétés, aux règles culturelles. Elle a toujours obéi à ça au fil du temps. Et c'est aussi pour répondre à ta question par rapport à l'homosexualité, comment elle s'est retrouvée, entre parenthèses, normalisée par les sociétés savantes.

(9:28 - 9:46)

Il faut savoir que pour chaque période, il y a une principale référence sexuelle. L'Antiquité romaine, la principale référence était la virilité. Le homme devait être viril, il ne devait pas être passif dans l'acte sexuel, je parle des hommes.

(9:47 - 10:19)

La passivité, c'est-à-dire, quand je dis la passivité, c'est l'homosexualité, elle était réservée surtout aux esclaves. Un homme libre ne devait pas être passif dans un acte sexuel. Après, on considérait que toute relation sexuelle avec un être qui a une couleur dark, elle était considérée comme contre-nature.

(10:20 - 10:44)

Donc, il ne pouvait pas y avoir des relations sexuelles entre des personnes noires de peau et des personnes blanches de peau. Après, on faisait référence à ce qu'on appelait l'instinct sexuel. C'est-à-dire, toute relation ou tout acte sexuel qui n'a pas pour objectif la reproduction, c'est-à-dire avoir des enfants, était considérée comme contre-nature.

(10:45 - 10:57)

Notamment l'homosexualité, les actes sexuels horogénitaux et autres. La masturbation aussi. Donc, tout acte sexuel qui n'a pas pour objectif la reproduction.

(10:58 - 11:20)

C'est là où ça vous intéresse pour répondre à votre question. Il faut savoir qu'à la fin du XXe siècle, l'homosexualité était considérée comme une pathologie. Les années 60, il y avait cette révolution sexuelle, la période des hippies, où la sexualité était banalisée.

(11:21 - 11:34)

On pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait dans les rues avec l'avènement du cannabis. La période des hippies, les années 60-70. Les hippies, finalement les hippies.

(11:38 - 12:10)

Une grande ouverture, une grande liberté plutôt sexuelle. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de sanctions par rapport à ça. Les associations d'homosexuels, à l'époque il y avait des associations d'homosexuels, dans les années 60-70, parce qu'ils avaient un poids, ils ont toujours un poids, ils ont beaucoup de poids.

(12:11 - 12:40)

Ils ont demandé une réunion avec les rédacteurs du DSM. Quand je dis rédacteurs du DSM, c'est des psychiatres qui font des réunions en chambre. Le DSM, c'est un comité de psychiatres, une centaine, et qui révisé pour chaque année les critères diagnostiques des pathologies.

(12:40 - 12:58)

Ils se mettent d'accord avec les sociétés savantes du Parlement. Soit on ajoute un critère, soit on le modifie, soit carrément on change de catégorie de pathologie. Le registre, par exemple, anxiété, registre, par exemple, dépression, autre.

(13:00 - 13:38)

Ça a toujours été causé par une réflexion scientifique. Dans cette situation-là, ces associations d'homosexuels qui sont parties voir les rédacteurs du DSM, ils leur ont dit que l'homosexualité ne devait pas être considérée comme une maladie. Et bien sûr, l'association DSM a enlevé l'homosexualité du chapitre des pathologies sexuelles.

(13:38 - 14:07)

Donc, si vous êtes dans un congrès et que vous traitez l'homosexualité comme pathologie, qu'est-ce qu'on va vous faire ? Vous voyez que la sexualité aussi, elle obéit aux changements des cultures. Je ne parle pas du DSM, je ne parle pas des convictions de chacun, je ne parle pas des convictions religieuses. Ce n'est pas dans un amphithéâtre qu'on va discuter ça.

(14:07 - 15:07)

Quand je vous parle du manuel diagnostique et statistique des pathologies psychiatriques, je dis qu'ils ne la considèrent pas comme étant un trouble. Pourquoi il faut connaître la physiologie de la sexualité ? Pardon, oui, mais pour pouvoir aussi l'expliquer aux patients. Après, je vous dirai une anecdote.

Je crois que vous avez vu la vidéo, mais je dirai une anecdote. Il faut savoir qu'il y a quatre phases de l'acte sexuel. Première phase, c'est la phase d'excitation.

(15:08 - 15:25)

Chez l'homme, c'est clair, elle aboutit à l'érection. Chez la femme, il y a une lubrification vaginale. La lubrification est importante, pourquoi ? Ça nous renvoie à quel type de pathologie ? Quand il n'y a pas une bonne lubrification.

(15:26 - 15:41)

Là, je vais introduire les troubles. Une douleur qu'on appelait vaginisme. La douleur peut être due à quoi ? Un trouble de la phase d'excitation.

(15:43 - 16:13)

Parfois, vous pouvez recevoir des patients qui ont des pathologies douloureuses, vaginisme ou autre. Quand vous analysez bien la situation, quand vous faites une anamnèse correcte, vous vous rendez compte que la phase d'excitation, il n'y a pas une phase d'excitation où là, elle n'est pas complète, où là, elle est insuffisante pour pouvoir avoir la lubrification. C'est juste un problème de lubrification.

(16:16 - 16:41)

Il y a une phase au plateau. La phase au plateau, c'est la phase d'excitation 1. L'acte sexuel, il va aboutir à l'orgasme chez la femme et chez l'homme. Chez l'homme, la phase d'orgasme se manifeste par l'éjaculation.

(16:42 - 17:22)

Chez la femme, c'est une sensation de plaisir intense avec contraction périnéale. La phase d'orgasme, pourquoi il y a un orgasme ? Parce qu'il y a surtout des contractions périnéales, que ce soit chez l'homme ou que ce soit chez la femme, d'accord ? Avec des modifications, des constantes, une augmentation légère de la tension artérielle, un sentiment d'essoufflement, etc. Il y a la phase au plateau, c'est la phase d'acte sexuel qui aboutit à l'orgasme.

(17:23 - 17:37)

Après l'orgasme, on avait dit que l'orgasme se termine par l'éjaculation. Il y a ce qu'on appelle la phase de résolution. Excusez-moi, voilà.

(17:40 - 17:54)

Phase plateau, deux et trois. Phase de résolution, quatre. La phase de résolution, c'est une phase qui est marquée par une diminution de tous les phénomènes qui existaient dans la phase

d'excitation.

(17:54 - 18:27)

C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'érection, la tumeissance commence à diminuer. Il faut savoir que dans la phase de résolution, la femme peut avoir un deuxième orgasme, c'est-à-dire qu'elle est prête déjà à avoir un deuxième orgasme après une simulation sexuelle. Chez l'homme, lors de la phase de résolution, aucune excitation n'est possible.

(18:28 - 19:02)

Je reviendrai à la phase d'orgasme. On avait dit que c'est une phase qui est de plaisir intense et qui se manifeste par des contractions périnéales, etc. Je ne sais pas si vous avez vu une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, je crois que c'est sur Shouf TV, je ne me rappelle plus, d'un homme qui voulait divorcer sa femme parce qu'elle avait exprimé un sentiment de plaisir au cours de l'acte sexuel.

(19:03 - 19:20)

Je ne sais pas si vous avez vu ça. Cette personne-là, allez voir la vidéo, je crois qu'elle existe toujours. Cette personne-là, la femme avait exprimé cette sensation de plaisir-là pour la première fois de sa vie.

(19:21 - 19:31)

Je crois que c'est un couple qui a des enfants. Le souci qu'il y a, c'était quoi le souci pour le marié ? C'est qu'il n'a pas pris ça pour un orgasme. C'est normal, c'est un orgasme.

(19:32 - 19:56)

Il a dit qu'il a appris ça avec quelqu'un d'autre. Forcément, elle le trompe. Ça peut paraître caricatural, mais ça témoigne d'une absence d'éducation sexuelle qui est grave pour quelqu'un qui doit avoir la quarantaine.

(19:58 - 20:22)

Et c'est un couple qui a des enfants. Et pour le malheur de la femme, la première fois qu'elle exprime ou la première fois qu'elle ressent un orgasme, elle se trouve dans les réseaux sociaux. Ça témoigne de quoi ? Si le mari savait que l'orgasme, il va aboutir à Hada, il y aura des sensations de plaisir, etc.

(20:24 - 20:49)

À votre avis, est-ce que ça aurait créé ce problème ? Il y a une absence d'éducation sexuelle comme pas possible et qui est grave et qui peut avoir des conséquences très négatives sur la vie

du couple. Ces personnes-là, forcément, vont divorcer avec une remise en question. Peut-être que même Hada et les enfants ne sont pas les miens.

(20:50 - 21:02)

Vous voyez la gravité de la chose ? Allez chercher cette vidéo. Allez la chercher. C'était en même temps caricatural et en même temps, ça faisait mal au cœur.

(21:05 - 21:25)

La classification. Il y a ce qu'on appelle les dysfonctionnements sexuels. Les dysfonctions sexuelles, c'est des troubles qui peuvent apparaître, qui peuvent concerner une de ces phases, soit l'excitation, soit la phase de l'acte sexuel, soit la résolution, etc.

(21:26 - 21:53)

Une des phases de l'acte sexuel. D'où la nécessité de connaître ces différentes phases et connaître les caractéristiques physiologiques de chaque phase. Qu'est-ce qui se passe ? Et à quoi ça aboutit ? Les dysfonctions sexuelles, pour parler déjà de dysfonctions ou de troubles dans le décès, il faut que ce soit plus de six mois.

(21:54 - 22:14)

Et que ce soit responsable du détresse personnel et ou du couple. Détresse, c'est les complications négatives. Chez l'homme, trouble de l'éjaculation retardée, clair ou pas ? C'est un retard à l'éjaculation.

(22:15 - 22:44)

Pourquoi c'est un délai marqué de l'éjaculation ? Pourquoi ça peut constituer une souffrance pour le couple ? Il va y avoir une éjaculation, mais elle est retardée dans le temps. C'est épuisant. L'acte sexuel, la résolution de l'acte sexuel chez l'homme, doit se terminer forcément par l'éjaculation.

(22:45 - 23:00)

Donc s'il n'y a pas d'éjaculation, il y aura toujours l'érection et l'acte sexuel va perdurer. Il n'y a pas un homme qui va terminer l'acte sexuel parce que sa partenaire est fatiguée. Donc là, c'est une cause d'épuisement du partenaire et problématique du couple.

(23:03 - 23:21)

Trouble de l'éjaculation prématurée ou précocité. Parfois, juste après l'intro-mission, il y a l'éjaculation. Pourquoi ça constitue un problème ? Pas d'orgasme chez la femme, elle est achetée.

(23:22 - 23:38)

Avec l'érection, il y a la phase 1. Avec l'érection, il y a l'éjaculation. Donc on a esquivé la phase 2 et la phase 3, on s'en va à l'éjaculation. Donc pas d'orgasme chez le partenaire.

(23:41 - 24:43)

Et trouble de l'érection, ce n'est pas uniquement l'absence de l'érection, mais l'incapacité soit d'obtenir l'absence carrément de l'érection ou de maintenir une érection suffisante pour la pénétration. Ça peut être une érection de mauvaise qualité et qui va entraîner aussi qu'il n'y ait pas d'orgasme chez le partenaire. Les dysfonctions sexuelles chez l'homme, éjaculation retardée, prématurée, trouble de l'érection sont des troubles les plus fréquemment rapportés par les hommes, par les patients, et ce sont des troubles qui sont sources d'une grande souffrance pour l'homme, un lèche, qui peut aller jusqu'à de réelles dépressions, dissolutions de couple, une agressivité au sein du couple, un lèche.

(24:47 - 25:07)

Ça touche la virilité, ça touche la masculinité. Un homme qui n'arrive pas à avoir une bonne érection ou une bonne éjaculation, il n'est pas considéré comme un homme dans sa tête. Ça peut entraîner de l'agressivité, de la violence au sein du couple, des dépressions graves chez les patients atteints.

(25:11 - 25:30)

Il y a aussi ce qu'on appelle les troubles de diminution du désir sexuel, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Soit un trouble du désir, soit une diminution des fantasmes sexuelles. Un homme ou une femme qui ne fantasme pas sexuellement a un trouble du désir sexuel.

(25:31 - 25:49)

Ce n'est pas uniquement le désir sexuel en lui-même, mais même les fantasmes sexuels. Chez la femme, trouble de l'orgasme, c'est l'incapacité à atteindre l'orgasme. Trouble de l'intérêt de l'excitation chez la femme, c'est comme chez l'homme.

(25:51 - 26:22)

Excitation absente, très réduite, absence de fantasme. Et ce qui est intéressant chez les femmes, rapporté fréquemment, c'est ce qu'on appelle les troubles liés à des douleurs génitopélviennes ou à la pénétration, ce qu'on appelait anciennement le vaginisme, les dyspareunies. C'est le souci avec, excusez-moi, voilà.

(26:25 - 26:47)

Je vous dis dès maintenant, RS, relation sexuelle. Quand il y a un trouble douloureux, qu'est-ce que vous voyez sur ce graphique-là ? Que ça peut entraîner les troubles sexuels, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, peuvent entraîner un cercle vicieux. Supposons, on va prendre un cas de figure.

(26:47 - 27:04)

Supposons qu'il y a des douleurs chez la femme lors des relations sexuelles. Ça va entraîner quoi ? Une anticipation. C'est qu'à chaque fois qu'il y aura un acte sexuel, je vais avoir mal.

(27:04 - 27:13)

Donc, ça va retentir sur le désir. Ça va diminuer le désir. Un trouble du désir chez la femme.

(27:14 - 27:30)

Quand il y a un trouble du désir chez la femme, ça va entraîner quoi ? Rappelez-vous. Qu'est-ce qu'il y a pour la phase de l'excitation ? Quand il y a le désir, il y a l'excitation. Qu'est-ce qu'il y a pour l'excitation ? Lubrification.

(27:31 - 27:40)

Quand il n'y a pas de lubrification, douleurs. Donc, vous voyez que ça va entraîner un cercle vicieux. Idem pour les autres troubles.

(27:40 - 28:11)

Et après, quand on entre dans ce cercle vicieux, c'est qu'on est entré dans la chronicité des troubles. Parfois, on reçoit des patients, on n'arrive même pas à savoir quel était le premier symptôme, quel est le symptôme essentiel qui a entraîné cette problématique sexuelle. Qu'est-ce qui a commencé d'abord ? Est-ce que c'était la douleur ? Est-ce que c'était le trouble du désir ? Est-ce que c'était le trouble de l'excitation ? Plus ça entre dans la chronicité, plus c'est difficile de diagnostiquer correctement, plus c'est difficile de prendre en charge.

(28:17 - 28:57)

Les paraphilies paras, c'est ce qu'on appelait avant les perversions sexuelles. Dans les perversions sexuelles, les intérêts sexuels ou le plaisir sexuel, il n'est pas orienté vers un acte sexuel, mais plutôt vers des objets plutôt que vers des personnes. Des activités sexuelles non généralement associées à une pénétration ou un orgasme ou une éjaculation qui est réalisée dans des circonstances étranges.

(28:57 - 29:20)

Les objets. Là ? On va voir. Voilà.

(29:22 - 29:31)

Le souci, ça je le laisserai à la fin. Le trouble exhibitionnisme. J'ai donné des exemples de troubles paraphiliques.

(29:31 - 29:50)

Exhibitionnisme, c'est quoi ? C'est exhiber, c'est se dénuder ou se montrer en public. Le plaisir sexuel est atteint quand la personne montre ses organes génitaux en public. Le trouble voyeurisme.

(29:50 - 30:05)

Voyeurisme, ça vient de voir. Le plaisir est atteint par le fait d'observer les actes sexuels des autres. Frotteurisme.

(30:08 - 30:19)

Frotteurisme, ça vient de se frotter contre quelqu'un. Pédophilie, non consentant. Masochisme.

(30:24 - 30:46)

Le plaisir est atteint quand on inflige à la personne une douleur. L'asphyxiophilie. Soit par l'étranglement, soit ça cause des accidents graves où les personnes peuvent mourir à cause de ça.

(30:48 - 30:55)

Sadisme. Le plaisir est atteint quand on inflige de la douleur à l'autre. Fétichisme, les objets.

(30:56 - 31:13)

Un objet fétiche. Fétichisme sexuel. Quels sont les types d'objets fétiches ? Pardon ? Les pieds, les chaussures, les vêtements, la lingerie, les slips, etc.

(31:13 - 31:35)

D'accord ? Le trouble transvestisme. Trans, c'est le plaisir sexuel est atteint quand on s'habille, quand on se déguise, quand on met les vêtements du sexe opposé. Autre paraphilie, zoophilie, urophilie, je passe.

(31:36 - 31:55)

C'est quoi le souci avec les troubles paraphiliques ? Par rapport aux dysfonctions sexuelles qu'on a vues. La dysfonction sexuelle qui atteint les phases de l'acte sexuel. Paraphilie, on avait compris c'est quoi.

(31:55 - 32:28)

Mais c'est quoi le souci avec la paraphilie ? Pardon ? Mais c'est quoi le souci ? Oui, c'est la dimension judiciaire. Parce que dans plusieurs troubles paraphiliques, peut-être qu'il n'y a pas le consentement du partenaire. Pédophilie, raptophilie, je sais la raptophilie.

(32:30 - 32:54)

Le plaisir est atteint que par les viols, les violeurs en série. Ce sont des personnes raptophiles, d'accord ? Sadisme, oui ou non ? Le plaisir est atteint quand on inflige la douleur au partenaire. Si le partenaire n'est pas consentant, d'accord ? Donc le souci avec les nécrophilies aussi.

(32:58 - 33:28)

Le souci avec les paraphilies, c'est qu'on peut faire du mal au partenaire. Et ça peut avoir des conséquences juridiques graves. Le trouble hypersexualité, nymphomanie chez la femme, satiriasie chez l'homme, sexualité compulsive ou impulsive.

(33:30 - 33:47)

Le souci avec l'hypersexualité, c'est qu'il n'y a pas de définition claire. On parle d'hypersexualité à partir de combien de rapports par jour, par semaine, par mois ? Il n'y a pas un critère qui quantifie l'hypersexualité. Pas de définition claire.

(33:48 - 34:23)

Mais surtout, la définition, c'est le fait de se livrer répétitivement à des fantasmes, des pulsions et comportements sexuels prenant un temps excessif et qui sont à l'origine de souffrances et conséquences néfastes. Ça vous renvoie à quelle définition, Haji ? Vous avez fait les addictions ? Ça renvoie plutôt à la définition des addictions. C'est le même principe, addiction aux substances comme addiction au sexe.

(34:26 - 35:16)

Dans le trouble hypersexualité, il y a une pensée envahissante, obsédante par rapport à la sexualité, perte de contrôle. L'acte sexuel devient un objectif ultime avec un sentiment de honte et de désespoir. Ça vous rappelle quoi ? La boue ? La crise ? Ça ne vous rappelle pas la définition, la crise boulimique ? Pensée obsédante, vouloir manger ? C'est un acte sexuel qui survient de façon impulsive et qui se termine par un sentiment de honte et de culpabilité.

(35:16 - 35:44)

Plusieurs formes cliniques à l'hypersexualité. La drague compulsive, recherche de partenaires sexuels multiples et situation très fréquente, motif de consultation fréquente, c'est la masturbation

compulsive. Par rapport à la masturbation chez les jeunes, qui survient dans un contexte je dirais normal, compulsive, c'est que ça vient répondre à un symptôme oxyeux important.

(35:44 - 36:17)

Une idée obsédante avec une angoisse importante dont la masturbation va diminuer l'angoisse, c'est-à-dire la masturbation compulsive. Plusieurs étiologies organiques, je passerai, je donnerai un exemple de certains médicaments par exemple les antidépresseurs, neuroleptiques, antihypertenseurs, etc. Ce qui nous intéresse surtout c'est les facteurs psychologiques et les pathologies psychiatriques, je vous libère dans 8 minutes.

(36:18 - 37:36)

D'accord ? C'est qu'on a une information sur la sexualité qui est absente ou erronée, l'exemple du fameux monsieur, l'absence de motivation, l'absence d'habilités sexuelles qui sont dues à une absence d'éducation sexuelle de qualité, c'est-à-dire on apprend ce qu'il faut apprendre sur l'acte sexuel. L'éducation sexuelle ce n'est pas aller voir les films pornographiques, l'éducation sexuelle c'est de comprendre l'acte sexuel et de comprendre les différentes phases et savoir sur quoi il faut jouer pour mener correctement un rapport sexuel. Les croyances dysfonctionnelles par rapport à notre pensée qui sont généralement inconscientes par rapport à la sexualité, dans notre contexte la sexualité est-elle considérée comme quoi ? Quelles sont les pensées dysfonctionnelles que vous connaissez par rapport à la sexualité ? Pardon ? Tabou ? Quoi encore ? Haram ? Oui ou non ? Avant le mariage, haram ? Quoi encore ? Quand on dit maintenant haram, il se peut que même après le mariage ça reste inconsciemment haram.

(37:37 - 38:11)

C'est de ça que je parle. Quoi encore ? Douloureux ? Oui ou non ? Douleur ? Donc qu'une idée pensée, même le fait de dire que c'est haram, il faut comprendre pourquoi c'est haram et dans quelle situation ce n'est plus haram. Quand vous dites haram, haram, haram, haram, oh là c'est douloureux, oh là c'est tabou, oh là c'est pas bien, c'est que vous ont créé dans la tête de l'enfant ou de l'adolescent cette idée et quand elle va se marier après, cette idée va ressortir.

(38:11 - 39:06)

C'est la seule idée, c'est la seule représentation qu'elle a de la sexualité. C'est pour ça que faire de l'éducation sexuelle aux enfants, c'est d'apprendre aux enfants à bien connaître leurs organes génitaux et puis dès qu'ils passent à d'autres périodes de la vie, puberté, adolescence, adulte jeune, donner de l'information qui est proportionnelle ou qui est correcte par rapport à son âge. Beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'expérience sexuelle, dès qu'ils veulent se marier, oh là comment c'est une expérience sexuelle, ils vont aller voir des films pornographiques, ils vont voir sur Internet et ce qu'on voit sur Internet, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la réalité, c'est des fantasmes, c'est des choses qui sont stage, c'est-à-dire que c'est de la mise en scène.

(39:07 - 40:01)

Le stress, les antécédents de violences physiques ou sexuelles pendant l'enfance, la consommation de toxiques, l'alcool, le tabac aussi, le cannabis et certains troubles psychiatriques qui peuvent entraîner des dysfonctionnements sexuels, des problématiques sexuelles, notamment la dépression, qui peut donner des troubles du désir, troubles du plaisir, une absence d'érection, des troubles anxieux aussi, des troubles de la personnalité. Certains facteurs stressants de la vie de la personne, la qualité de la relation au sein du couple, l'incompatibilité au niveau personnel au sein du couple, des gens qui n'ont aucun point en commun, qui ne s'aiment pas, qui ne se connaissent pas. Bien sûr, ça va retentir sur la sexualité.

(40:02 - 40:51)

La fonction sexuelle du partenaire quand il n'est pas expérimenté, qui a lui-même une dysfonction sexuelle, un partenaire qui n'est pas disponible et des facteurs culturels, notamment, c'est ce qu'on a vu, les différents tabous sexuels. Origines multifactorielles, conséquences, grande souffrance psychique chez le couple, perte de l'estime de soi, culpabilité, altération de la qualité relationnelle et des complications psychiatriques, notamment la dépression. Vous l'avez bien signalé, des complications juridiques chez le parafil.

(40:56 - 41:50)

Pourquoi c'est difficile d'aborder le sujet ? Vous l'avez bien dit, la peur de ne pas savoir comment aborder, le manque de temps, vous avez 60 patients qui vous attendent, qui attendent votre consultation, le manque de formation, être gêné par rapport au fait d'évoquer un sujet tabou, la différence d'âge avec le patient, aussi la différence du sexe. Imaginez, jeune médecin, sexe féminin, avec un patient âgé, 70 ans, de sexe masculin, ça va être difficile de parler de la sexualité avec quelqu'un qui a l'âge de votre papa ou de votre grand-père carrément. D'accord ? La crainte de réaction des patients, quand vous leur posez un sujet, une question aussi intime que ça, et la difficulté de décrypter les non-dits.

(41:51 - 42:25)

C'est quoi les non-dits ? Ce que va insinuer le patient pour vous dire qu'il a un problème sexuel. Pour le patient, bien sûr l'âge, les représentations, certains cas particuliers que je vais relater, c'est la sexualité chez le sujet âgé et la sexualité des personnes qui ont des pathologies lourdes, notamment le cancer. C'est des personnes qu'on considère la fin de leur vie.

(42:26 - 42:42)

Le sujet âgé, ce n'est pas la sexualité qui est importante. Une femme qui a le cancer, un homme qui a le cancer, la sexualité, elle est secondaire. Non, c'est important aussi d'évoquer, de la part du médecin et aussi de la part du patient.

(42:43 - 43:14)

J'ai le cancer, que va dire mon médecin si je lui pose une question concernant ma dysfonction sexuelle ? Il va dire qu'il ne lui reste que ça à faire. Vous voyez que ce sont des situations qui peuvent être source de gêne pour le patient. Comment aborder la sexualité ? Une astuce qui ne rate presque jamais, c'est parler sur un registre médical.

(43:16 - 43:36)

Parlez de la santé sexuelle et non pas de la sexualité. Toujours faites entrer le terme santé. Quand vous faites entrer le terme santé, c'est que déjà, vous ne parlez pas de sexualité, mais vous parlez de santé sexuelle, donc ça fait partie de ma santé.

(43:37 - 43:51)

Parlez sur un registre médical. Vous avez un patient qui est hypertendu, qui est sous antihypertenseur. Vous suspectez chez lui d'un trouble sexuel, une dysfonction, ou bien vous êtes en train de faire un dépistage de dysfonction sexuelle.

(43:52 - 44:11)

Vous savez, monsieur, plusieurs personnes qui sont hypertendues et qui prennent le même type de traitement ont des problématiques de dysfonction sexuelle ou ont des problématiques de leur santé sexuelle. Est-ce que c'est le cas pour vous ? Et là, vous avez parlé sur un registre médical. Et posez aussi des questions ouvertes.

(44:11 - 44:37)

Vous ne leur dites pas, est-ce que vous avez un dysfonctionnement sexuel ? Est-ce que vous avez un problème de désir ? Est-ce que vous avez un problème de plaisir ? Comment ça va par rapport à votre vie intime ? Pour les gens qui comprennent un peu. Et vous posez une question ouverte, pas de question fermée. Surtout, toujours parler sur un registre médical.

(44:37 - 44:46)

Utilisez le terme santé sexuelle. Laissez au patient le temps de réflexion, le temps qu'il analyse. Osez les questions.

(44:46 - 44:54)

Ne pas prendre partie quand il y a une problématique. Non, c'est elle qui ne lubrifie pas, non, c'est lui qui a une mauvaise érection. Ne prenez pas partie.

(44:54 - 45:04)

Essayez d'analyser de façon objective le problème. Évitez tout jugement personnel. Parlez de santé sexuelle.

(45:05 - 45:10)

Utilisez des termes simples et précis, c'est clair. Et la communication non verbale. Repérez les non-dits.

(45:11 - 45:21)

Vous avez un patient qui est gêné et qui tourne autour du pot. Vous savez, je me dispute beaucoup avec ma femme. On a des problèmes.

(45:22 - 45:32)

On ne dort pas dans la même chambre. Elle est là en train de vous dire, mais posez-moi la question. Dites-moi pourquoi vous ne dormez pas dans la même chambre.

(45:32 - 45:49)

Dites-moi pourquoi vous vous disputez avec votre femme. Quelqu'un qui a des non-dits, il faut savoir les repérer. Quand est-ce qu'il faut aborder la sexualité ou la santé sexuelle? Première consultation avec tout patient.

(45:50 - 46:06)

À la demande explicite du patient. Et dans certaines situations cliniques particulières qui peuvent évoquer un problème de sexualité, notamment toute IST chez un homme ou chez une femme. Chez les patients, il y a un problème de sexualité.

(46:06 - 46:13)

Chez des patients qui prennent certains médicaments. Chez des patients qui ont des pathologies chroniques. En post-chirurgie de cancer.

(46:14 - 46:27)

Et lors des périodes importantes de la vie d'une personne. Puberté, grossesse, post-partum, ménopause. D'accord? C'est important, donc je laisserai.

(46:27 - 46:34)

On est arrivé à l'examen sexologique. Je laisserai à la séance prochaine. Et je vous remercie.